

国健医疗

四诊合参体质辨识报告

开封市龙亭区 1234452345

患者信息：

姓名：	二分是	性别：	男	年龄：	20岁	生日：	2006-04-12
住址：							

四诊初步诊断

望诊（舌象分析）



舌苔图

核心证候为脾虚湿盛兼轻度气阴两虚。舌质淡红偏淡，舌体略胖、边有轻微齿痕，苔薄白润，舌面湿润无燥裂，提示脾失健运、水湿内停；舌尖稍红、舌中根部略显淡，反映中焦气虚兼轻度虚热。建议：①饮食宜温补健脾，如山药、莲子、薏苡仁煮粥；②忌生冷油腻及甜食，以防助湿伤脾。

补充分析

- 舌象结果已提示当前舌体与舌苔特征，建议与饮食、睡眠、情绪状态一起观察。
- 这类表现通常和运化偏弱、湿邪偏重有关，日常可留意清淡饮食与作息规律。
- 目前变化偏轻，重在早期干预和持续观察，避免继续累积疲劳与饮食失衡。
- 如果后续还有闻诊、问诊或切诊结果，可进一步提高整体辨证的稳定性。

闻诊（体质诊断）

诊断结论：气滞血瘀
置信度：84.0%

体质标签：气机不畅音调波动声音不连贯

补充分析

- 当前闻诊置信度为 84.0%，可作为参考，但不建议单独定性。
- 体质标签显示：气机不畅、音调波动、声音不连贯，说明声音特征与当前体质倾向存在一定关联。
- 若日常出现乏力、气短、咳嗽或情绪波动，建议结合具体症状继续观察。

问诊（症状问卷）

专项问诊结论

气虚质

气虚质

常见精神不足、容易疲劳、气短懒言等表现，调理重点在于补气养气与适度活动。

补充分析

- 本次得分靠前的是：气虚质13分、气郁质12分、湿热质12分，可作为后续调理重点。
- 问卷分析适合与望诊、闻诊和切诊结果联动解读，不宜单独下结论。
- 若主诉症状持续存在，建议结合睡眠、饮食、情绪和运动习惯一起评估。
- 可按 1-2 周为周期复盘症状变化，结合复测结果动态调整调理重点。

饮食建议

- 可多吃山药、莲子、红枣、黄豆等温和食材
- 饮食宜少量多餐，避免过饱
- 汤粥类和熟食更适合日常调养

禁忌提醒

- 避免过度节食
- 避免长期吃生冷寒凉食物
- 避免高强度、超负荷运动

后续建议

- 保证充足睡眠，减少熬夜
- 选择散步、八段锦等轻中度运动
- 如乏力明显或持续加重，建议线下复诊

切诊（脉搏检测）

心率：74.1 bpm

血氧：99.4 %

信号有效率：98.7 %

采样数：148

中医建议：

【结论性质】本结果基于PPG自动分析，仅反映当前时段脉搏特征倾向，不等同于临床确诊。【融合判定】缓脉倾向（多特征融合）【区分度】主次得分差=1.0（越高表示判定越稳定）【融合得分】数=0.0，迟=1.0，缓=2.0【脉象倾向】缓脉范围（心率中等）【脉搏特征】缓脉倾向、节律较齐、脉势偏弱、脉形偏缓、证据:心率中段(74.1bpm)、证据:节律较齐(CV=0.0449)、证据:灌注偏弱(PI=0.7257)【量化摘要】RMSSD=25.009ms，节律CV=0.0449，灌注指数PI=0.7257%。

补充分析

- 当前心率 74.1 bpm、血氧 99.4%，可作为循环与呼吸状态的基础参考。
- 信号有效率 98.7%、采样数 148，说明本次测量质量具备一定参考价值。
- 脉搏分析已给出中医建议，可与舌象和问卷结果一起综合判断。

AI 详细分析

不侧重模式下，将进行更充分的跨板块综合分析与分层建议。

结论摘要

- 核心证候为脾虚湿盛，兼有气虚与气滞。**望诊舌象（舌淡胖、苔白润）与问卷结果（气虚质最高分）共同支持脾虚湿盛、中气不足；闻诊提示“气滞血瘀”，与问卷中气郁质次高分形成交叉印证。
- 存在轻度气阴两虚与虚热倾向。**望诊舌象显示“舌尖稍红、舌中根部显淡”，舌色偏红指数（40分）与偏淡指数（60分）并存，提示气虚基础上伴有轻微虚热；问卷中湿热质得分并列第二，也提示体内有湿郁化热的可能。
- 生理机能基础尚可，但气血运行偏缓偏弱。**切诊显示心率、血氧正常，但脉象呈“缓脉倾向、脉势偏弱”，灌注指数（PI=0.7257%）偏低，符合气虚推动无力、气血运行不畅的推断。
- 调理应以健脾益气、化湿行滞为核心。**证据链指向脾虚为病之本，湿盛、气滞为病之标，调理需标本兼顾，避免单纯清热或过度滋腻。

四诊综合解读

- 望诊 (舌象):** 算法结论为“脾虚湿盛兼轻度气阴两虚”。关键依据在于舌色偏淡指数高 (60分), 结合舌体胖、边有齿痕, 苔薄白润, 是典型的脾虚失运、水湿内停之象。舌色偏红指数中等 (40分) 且舌尖稍红, 提示存在轻度虚热或上焦郁热。津液亏虚指数低 (15分) 说明无明显伤阴, 湿重于燥。
- 闻诊 (音频):** 算法以较高置信度 (0.84) 判定为“气滞血瘀”。标签“气机不畅”、“声音不连贯”及音频特征中较高的基频标准差 ($f0Std=294.19$) 和抖动 ($jitter=0.0234$), 共同指向情绪或气机郁滞, 影响了声音的流畅与稳定。此为功能性的气机失调证据。
- 问诊 (问卷):** 算法结论为“气虚质”。体质评分显示气虚质 (13分) 为最主要偏颇, 气郁质 (12分) 与湿热质 (12分) 并列其次。这构成了“气虚为本, 气郁、湿热为标”的体质基础, 解释了为何会出现脾虚湿停与气机不畅并见的情况。
- 切诊 (脉象):** 算法提示“缓脉倾向、脉势偏弱”。关键依据为心率正常 (74.1bpm) 但缓脉融合得分最高 (2.0), 且灌注指数 ($PI=0.7257\%$) 偏低, 节律变异系数 ($CV=0.0449$) 较小。这符合气虚推动无力、气血灌注欠佳的脉象特征, 与望诊、问诊的“气虚”证据相呼应。

跨板块证据整合

各板块证据呈现高度协同与互补关系, 共同描绘出“本虚标实”的病机画面:

- 协同证据 (脾虚气虚):** 望诊的“舌淡胖、齿痕”与问诊的“气虚质”高度一致, 共同确立了“脾虚气虚”这一核心病机。切诊的“缓脉、脉势弱”为此提供了功能层面的佐证, 表明气虚已影响到气血运行。
- 互补证据 (湿、滞、热):** 望诊明确了“湿盛” (苔白润) 的病邪性质; 闻诊与问诊 (气郁质) 则共同揭示了“气滞”这一病理状态, 解释了湿邪为何难化。望诊的“舌尖红”与问诊的“湿热质”倾向, 则共同指向了湿邪可能郁而化热的趋势, 但当前热象不重。
- 整合取舍:** 闻诊的“血瘀”结论 (气滞血瘀) 与其他板块的直接证据 (如舌象瘀血指数仅5分) 关联较弱。因此, 将其解读为“气滞”的延伸或早期阶段更为合理, 即“气为血之帅”, 气机不畅日久可影响血行, 但目前以功能性的气滞为主, 尚未形成明显的器质性瘀血征象。

体质/证候判断

- 主要证候/体质:** 脾虚湿盛证, 体质以气虚质为主。此结论置信度高, 因有舌象 (形态、色泽、苔质)、体质问卷 (核心高分) 及脉象 (缓、弱) 三个独立板块的强有力支持。
- 次要倾向:** 兼夹气机郁滞 (气郁), 并有轻度郁热倾向。气郁由闻诊特征与问卷次高分支持; 郁热由舌象局部特征与湿热质倾向提示, 但证据强度弱于主证。
- 结论置信度来源:** 主要证候证据来自多板块交叉验证, 逻辑自洽。次要倾向中, 气郁的证据较郁热更为直接和一致。整体判断基于现有数据质量较高 (如切诊质量等级“高”, 闻诊置信度“0.84”), 故可信度较高。

分层调理建议

近期调理 (1-2周): 健脾化湿, 疏理气机

- 饮食:**
 - 主食以小米、大米、山药、莲子熬粥, 可加入少许茯苓或薏苡仁 (炒制) 以健脾渗湿。
 - 菜肴多选用白萝卜、陈皮、香菜等有助于行气化湿的食材。
 - 适量饮用陈皮普洱茶或大麦茶, 以醒脾理气。
 - 严格忌口生冷瓜果、冰镇饮品、油腻甜食 (如糕点、奶茶), 以免加重脾湿。
- 作息:**
 - 保证晚11点前入睡, 避免熬夜耗气。
 - 午餐后避免立即午睡, 可散步10分钟以防湿困中焦。
 - 保持居住环境干燥通风, 避免外湿引动内湿。
- 运动:**
 - 每日坚持散步或快走30-40分钟, 以微汗为度, 促进气机流通。
 - 练习八段锦, 重点加强“调理脾胃须单举”和“两手托天理三焦”两式。
- 穴位/经络:**
 - 每日按揉足三里穴、丰隆穴各3-5分钟, 以健脾化痰湿。
 - 睡前推搓两胁肋部 (肝经循行区域) 30次, 以疏肝理气。

- **禁忌：**
 1. 忌暴饮暴食，加重脾胃负担。
 2. 忌思虑过度，避免肝气郁结乘脾。
 3. 忌久坐不动，导致气机壅滞。

中期调理（1-3月）：巩固脾胃，调和气血

- **饮食：**在近期基础上，可逐步加入黄芪、党参等药食同源之品煲汤（如黄芪炖鸡），但需观察舌苔，如变腻则暂停。坚持饮食禁忌。
- **作息：**形成稳定的作息规律，尤其重视子午觉（夜间与午间小憩）的养护作用。
- **运动：**将八段锦或太极拳作为固定锻炼项目，逐步增加运动时长与强度，以增强体质。
- **复评建议：**建议1个月后重点复查舌象与脉象，观察舌体胖大、齿痕及脉势有无改善。若出现明显口干、舌苔变黄等化热迹象，需及时调整方案。

报告生成时间：2026/4/18 00:21:20

本系统仅为中医诊断辅助工具，不具备医疗资质，输出结果仅供参考，不能替代专业中医师面诊及诊疗方案

签发医师：张翰

3个月